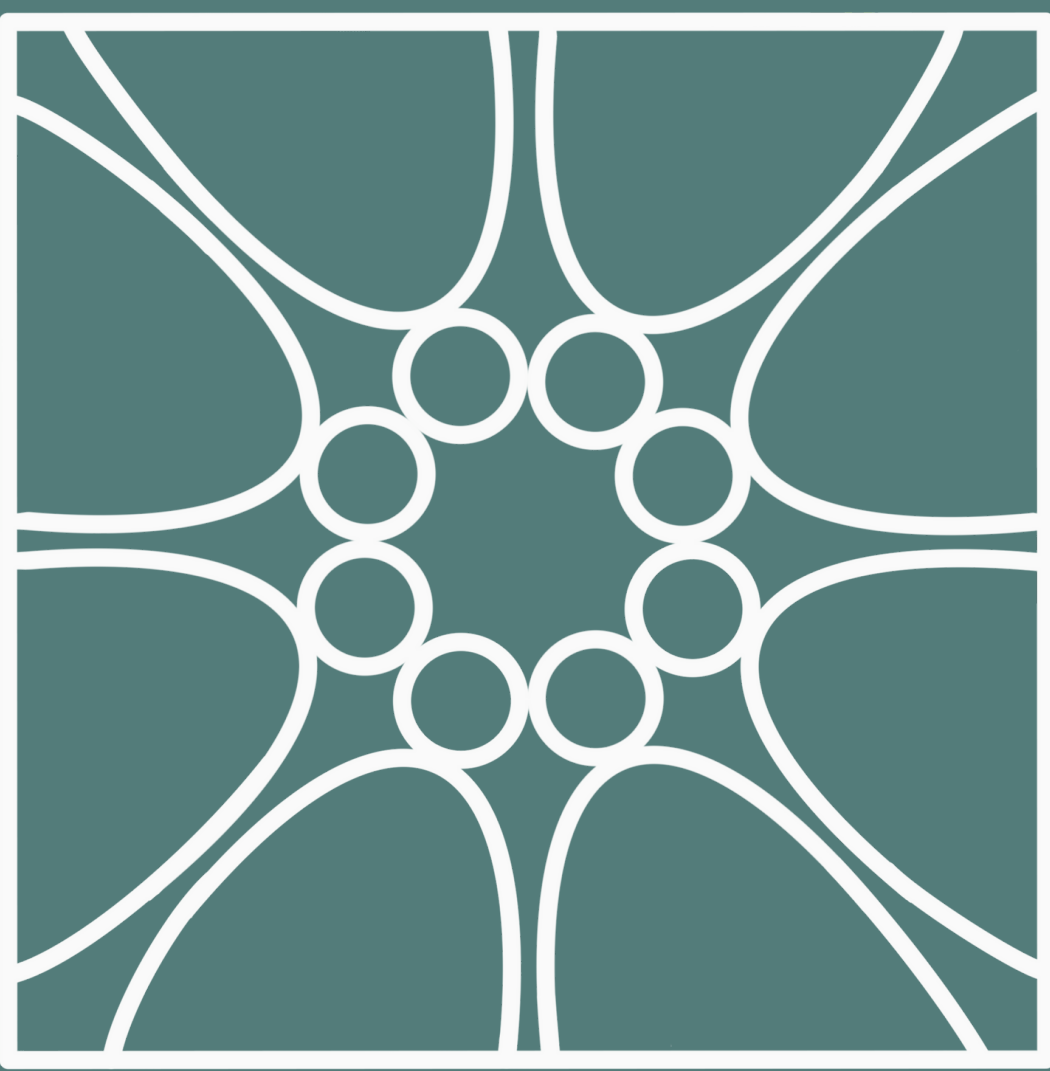


Aide-mémoire de la présentation de cas

Avant de présenter :

- Ouvrez le dossier du.de la patient.e
- Remémorez vous l’histoire et définissez vos objectifs
- Prenez connaissance des derniers résultats de labo, imagerie, etc.



Structure initiale de toutes les présentations :

1. Se présenter (fonction + service, +/- hôpital)
2. Annoncer le but de l’interaction ou de l’appel
3. Annoncer le degré d’urgence si nécessaire
4. Présentation du.de la patient.e :
 - ISBAR :
 - Identity - Situation - Background - Assessment - Recommandation
 - En fonction de l’âge, ajouter si nécessaire :

Pédiatrique

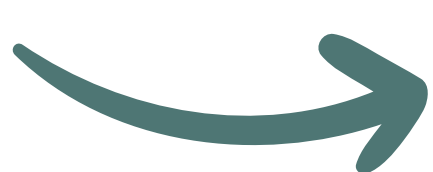
- Age
- Histoire de grossesse, accouchement, périnatalité, croissance
- Maladies/malformations congénitales
- Statut vaccinal
- Développement moteur et cognitif
- Alimentation et sommeil

Gériatrique

- Age
- IMU (instruction médicale d’urgence)
- Objectifs de soins
- Cognition - MOCA
- Statut nutritionnel
- Autonomie pour activités quotidiennes
- Réseau social et soutien familial



Selon la spécialité, considérer l’ajout de certains éléments à l’ISBAR



Aide mémoire des spécialités

Psy

- Facteurs de risques (suicide, agressivité, etc.)
- Atcd psy
- Stress actuel
- Usage de drogues
- Traitement et suivi psychiatrique
- MOCA/MMS

Gyneco-obst

- Gestité - parité
- Grossesse actuelle et SA
- SV : TA, pouls, T
- stix urinaire (prot, nitrites)
- bHCG
- FSC
- RAI et groupe sanguin
- US

Cardio

- Facteurs de risques CV
- Atcd cardio
- Ttt cardio
- Signes vitaux cardiaques
- ECG, US
- Troponine, CK-MB, BNP
- Fonction rénale

Endocrino

- Diabète 1 ou 2
- HbA1c
- Atcd endocrino
- Ttt
- Administration stéroïdes
- Habitudes nutritionnelles

Gastro

- Facteurs de risque hépatite (voyage,...) + cirrhose + ulcères
- Cognition
- Signes de saignements GI
- Labo hépato + pancréatique + anémie
- CHILD PUGH
- Etat de jeûne

Neuro

- Glasgow
- Score AVC
- Status neuro
- Dysfonction actuelle
- Imagerie cérébrale

Hemato

- Symptômes B
- Numération sanguine
- Coagulation et hémostase
- Résultat de ponction de moelle

Nephro

- Etiologie de la pathologie rénale
- Fonction rénale initiale vs actuelle
- Protéinurie
- Volémie
- Pression artérielle

Pneumo

- Symptômes respiratoires
- Exposition respiratoire et tabagisme
- Fonctions respiratoires (spirométrie, etc)

ORL

- Etat des Voies aériennes
- Acousie, vertige, acouphène, douleurs
- Fumeur
- Histoire onco
- Contage

Dermato

- Type de lésion (taille, couleur, texture,...)
- Topographie
- Groupement
- Prurit
- Exposition
- Traitement corticoïde

Soins intensifs / Urgences

- Signes défaillance organes (signes vitaux, gazo, labo, ...)
- Critères d’hosp aux SI
- Prise en charge faite (amines, ventilation)
- IMU

Chirurgie

- Stabilité hémodynamique
- Atcd chirurgies
- Atcd complications post-op
- Imageries
- Etat de jeûne
- Douleur
- Signes infectieux
- Transit

Ortho

- Douleur
- Mécanisme lésionnel
- Membre dominant
- Etat physique ant.
- Impotence fonction
- Atteinte neuro-vasc
- Atteinte cutanée
- Stabilité hémodynamique
- Rx

Radio

- Degrés d’urgence
- Contexte clinique
- Raison de la demande radio
- Zone à examiner
- Résultats d’imageries antérieures